

WhatsApp-Chatverlauf (Export)

Teilnehmer: Julian Arendt, Meike Vogt (Schwerbehindertenvertretung Bergische Anlagenbau GmbH)

[12.06.26, 11:48:03] Julian Arendt: Ich musste eben aus der Baustellenrunde raus. Es ging alles durcheinander, drei Leute gleichzeitig, keine Agenda. Ich konnte nicht mehr.

[12.06.26, 11:52:17] Meike Vogt: Alles gut, Julian. Geh nach Hause, wenn es sein muss. Ich vermerke das als reizbedingte Überlastung, nicht als Leistungsverweigerung.

[12.06.26, 12:03:41] Julian Arendt: Danke. Ich bin die nächsten Tage vermutlich krank. Kopf platzt.

[12.06.26, 12:05:09] Meike Vogt: Verstanden. Wichtig für das BEM und den Widerspruch: Es liegt an den spontanen Wechseln und dem Großraumbüro, nicht an der Aufgabe selbst.

[15.06.26, 08:31:22] Julian Arendt: War zwei Tage komplett platt. Migräne, kein Schlaf. Heute wieder da.

[26.06.26, 16:14:55] Meike Vogt: BEM-Einladung ist raus für heute datiert. Ich sitze mit drin. Wir schreiben rein: schriftliche Aufgabensteuerung, keine spontane Telefonvertretung, Rückzugszeiten.

[26.06.26, 16:20:38] Julian Arendt: Bitte auch, dass ich arbeiten WILL. Im Bescheid klingt es so, als sei alles ok, weil ich noch da bin. Das stimmt nicht.

[26.06.26, 16:22:04] Meike Vogt: Genau das sage ich der Rentenberaterin auch als Vertrauensperson. Deine Leistung ist top, wenn der Rahmen stimmt. Das ist der Punkt.

[01.07.26, 09:05:11] Julian Arendt: Widerspruch ist raus. Ostermann sagt, mit den Facharztwerten könnten wir auf 50 kommen.

[01.07.26, 09:07:49] Meike Vogt: Sehr gut. Ich hänge meine schriftliche Stellungnahme als Vertrauensperson an. Halte durch.

Von	julian.arendt@example.invalid
An	rentenberater@example.invalid
Datum	Sun, 28 Jun 2026 18:12:00 +0200
Betreff	Bitte keine Formulierung, als wäre ich arbeitsunwillig

Guten Abend Frau Ostermann,

mir ist für den Widerspruch wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, ich wolle nicht arbeiten. Ich bin seit neun Jahren technischer Zeichner und erledige die konstruktiven Aufgaben zuverlässig, wenn Arbeitsaufträge schriftlich kommen und ich nicht gleichzeitig telefonisch, im Großraumbüro und über den Gruppenchat angesprochen werde. Am 23. Juni wurde während einer Planänderung der Feuersalarm getestet. Danach konnte ich noch etwa vierzig Minuten am Bildschirm sitzen, habe aber keine Sprache mehr herausbekommen und musste von Frau Vogt in den Ruheraum begleitet werden. Zu Hause lag ich bis zum nächsten Morgen im abgedunkelten Schlafzimmer.

Der Bescheid erwähnt nur, dass ich weiter voll beschäftigt bin. Er enthält nichts dazu, dass ich seit November 2025 an 19 Tagen kurzfristig ausgefallen bin, zweimal wegen Reizüberlastung abgeholt wurde und für Besprechungen inzwischen eine schriftliche Tagesordnung brauche. Beim BEM am 8. Juli sollen ein fester Arbeitsplatz, Kopfhörer, keine spontanen Raumwechsel und zwei Tage mobiles Arbeiten besprochen werden.

Bitte schreiben Sie zugleich nicht, ich sei im Alltag vollständig hilflos. Ich wohne allein, kaufe mit Liste ein und fahre vertraute Strecken selbst. Schwierigkeiten entstehen vor allem bei Wechseln, unklaren Erwartungen und dichtem sozialen Kontakt. Den Bericht der Autismusambulanz vom 14. Mai und die Fehlzeitenliste habe ich angehängt. Frau Meike Vogt darf zu den Vorfällen am Arbeitsplatz befragt werden.

Freundliche Grüße

Julian Arendt

Friedrich-Engels-Allee 162, 42285 Wuppertal

Telefon 0157 204 88 631

Datei: eml/01_versorgungsamt_eingangsbestaetigung.eml

Von	Versorgungsamt Wuppertal - Widerspruchsstelle <widerspruch@versorgungsamt-wuppertal.example.invalid>
An	rentenberater@example.invalid
Datum	Fri, 03 Jul 2026 09:41:00 +0200
Betreff	Eingangsbestätigung Widerspruch - GdB Julian Arendt, Az. SB 30-114-2026

Sehr geehrte Frau Ostermann,

wir bestätigen den Eingang Ihres Widerspruchs vom 01.07.2026 gegen den Feststellungsbescheid vom 19.06.2026 (weiterhin GdB 30) in der Sache Julian Arendt, geboren am 28.07.1988.

Der Vorgang wird dem Ärztlichen Dienst zur erneuten versorgungsärztlichen Stellungnahme vorgelegt. Die früher erstellte gutachterliche Stellungnahme vom 09.06.2026, die dem Ausgangsbescheid zugrunde liegt, fügen wir Ihnen auf Ihren Antrag hin zur Akteneinsicht bei.

Wir weisen darauf hin, dass eine Neubewertung des Gesamt-GdB nicht durch Addition der Einzelgrade erfolgt, sondern nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen unter Würdigung der wechselseitigen Auswirkungen. Ergänzende Befunde können Sie bis zum Abschluss der Prüfung nachreichen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

B. Kortmann

Versorgungsamt Wuppertal, Widerspruchsstelle

Datei: eml/02_facharzt_befunduebersendung.eml

Von	"Praxis Dr. Reinsch - Psychiatrie" <praxis@nervenarzt-reinsch.example.invalid>
An	rentenberater@example.invalid
Datum	Mon, 29 Jun 2026 14:07:00 +0200
Betreff	Befundübersendung und GdB-Einschätzung Julian Arendt

Sehr geehrte Frau Ostermann,

wie besprochen übersende ich Ihnen für das Widerspruchsverfahren meinen ergänzenden nervenärztlichen Befundbericht (gesonderte Anlage) zu Herrn Julian Arendt.

Aus fachärztlicher Sicht sind mehrere Funktionsbeeinträchtigungen getrennt zu bewerten. Die Autismus-Spektrum-Störung mit ausgeprägter sensorischer Reizempfindlichkeit und erheblichen Anpassungsschwierigkeiten im Arbeitsleben schätze ich für sich genommen im oberen Bereich ein. Hinzu treten eine rezidivierende depressive Störung, die kombinierte ADHS und eine chronische Migräne mit eigenständigen Auswirkungen.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die stationäre Krisenintervention im Januar 2026 und die Meltdown-Episoden im Ausgangsbescheid nicht auftauchen. Der bloße Umstand fortbestehender Erwerbstätigkeit belegt keine geringe Teilhabebeeinträchtigung; die Tätigkeit gelingt nur unter hoher Kompensation und bricht bei Reizüberlastung wiederholt zusammen.

Für Rückfragen der versorgungsärztlichen Stelle stehe ich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. Thomas Reinsch

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Wuppertal

Datei: eml/03_bevollmaechtigte_gdb_bildung.eml

Von	Katrin Ostermann - Rentenberatung <rentenberater@example.invalid>
An	Versorgungsamt Wuppertal - Widerspruchsstelle <widerspruch@versorgungsamt-wuppertal.example.invalid>
Datum	Fri, 03 Jul 2026 16:52:00 +0200
Betreff	WG: GdB Julian Arendt - Gesamt-GdB-Bildung und Akteneinsicht, Az. SB 30-114-2026

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Kortmann,

vielen Dank für die Eingangsbestätigung und die Übersendung der
gutachterlichen Stellungnahme vom 09.06.2026.

Nach Durchsicht ergibt sich der Streitpunkt präzise: Der Ärztliche Dienst
setzt die Autismus-Spektrum-Störung mit einem Einzel-GdB von nur 30 an und
bewertet die rezidivierende depressive Störung mit 20, ohne eigenständige
Steigerung. Der behandelnde Facharzt und die Autismusambulanz kommen zu einem
führenden Einzelwert von 40 für die ASS und 30 für die depressive Störung.

Wird die ASS mit 40 als führend angesetzt und die davon abgrenzbare
depressive Störung integrativ berücksichtigt, ist ein Gesamt-GdB von 50
plausibel; damit wäre die Schwerbehinderteneigenschaft erreicht. Eine
schlichte Fortschreibung des Wertes 30 ist nicht begründbar. Ich bitte, die
beigefügte Bewertungstabelle und die nachgereichten Befunde der erneuten
Prüfung zugrunde zu legen.

Um Akteneinsicht in die vollständige Verwaltungsakte wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Katrin Ostermann

Rentenberaterin (Rechtsdienstleistungsregister)

Datei: 05_alltags_und_reizprotokoll.csv

datum	auslöser	reaktion	folge	beleg
2026-05-07	Großraumbüro und Telefonkette	Shutdown	AU Folgetag	Arztmail
2026-05-19	spontane Prioritätsänderung	Konflikt mit Teamleitung	Abmahnung angedroht	Teamnotiz
2026-06-12	Baustellenrunde ohne Agenda	Raum verlassen	2 Tage AU	BEM-Akte
2026-06-23	schriftlicher Plan und Homeoffice	stabil	volle Leistung	Zeichnungsfreigabe

Datei: 09_gdb_bewertungstabelle.csv

rang

1

funktionsbeeinträchtigung

Autismus-Spektrum-Störung mit Anpassungs- und Reizverarbeitungsstörung

funktionssystem

Psyche

einzel_gdb_facharzt

40

einzel_gdb_versorgungsamt

30

überschneidung_mit_führend

führend

integrationsschritt

Ausgangswert

zwischenstand_gesamt_gdb

40

rang

2

funktionsbeeinträchtigung

Rezidivierende depressive Störung

funktionssystem

Psyche

einzel_gdb_facharzt

30

einzel_gdb_versorgungsamt

20

überschneidung_mit_führend

teilweise eigenständig

integrationsschritt

hebt führenden Wert um 10

zwischenstand_gesamt_gdb

50

rang

3

funktionsbeeinträchtigung

ADHS kombinierter Typ

funktionssystem

Psyche

einzel_gdb_facharzt

20

einzel_gdb_versorgungsamt

0

überschneidung_mit_führend

weitgehend deckungsgleich mit ASS

integrationsschritt

keine weitere Steigerung

zwischenstand_gesamt_gdb

50

rang

4

funktionsbeeinträchtigung

Chronische Migräne

funktionssystem

Kopf und Nerven

einzel_gdb_facharzt

10

einzel_gdb_versorgungsamt

10

überschneidung_mit_führend

gering

integrationsschritt

GdB 10 hebt regelmäßig nicht

zwischenstand_gesamt_gdb

50

rang

5

funktionsbeeinträchtigung

Ergebnis plausible Bildung

funktionssystem

gesamt

einzel_gdb_facharzt

0

einzel_gdb_versorgungsamt

0

überschneidung_mit_führend

0

integrationsschritt

integrativ nach VersMedV keine Addition

zwischenstand_gesamt_gdb

50

rang

6

funktionsbeeinträchtigung

Bescheid-Gesamt-GdB vom 19.06.2026

funktionssystem

gesamt

einzel_gdb_facharzt

0

einzel_gdb_versorgungsamt

0

überschneidung_mit_führend

0

integrationsschritt

festgestellter Wert

zwischenstand_gesamt_gdb

30

rang

7

funktionsbeeinträchtigung

Kontrollwert falsche Addition

funktionssystem

gesamt

einzel_gdb_facharzt

0

einzel_gdb_versorgungsamt

0

überschneidung_mit_führend

0

integrationsschritt

40 plus 30 plus 20 plus 10 wäre fehlerhaft

zwischenstand_gesamt_gdb

100

Datei

Office-Dokument: 01_mandatsnotiz_neurodivergenz.docx

Mandatsnotiz Neurodivergenz und Arbeit

1. Mandant

Mandant ist Julian Arendt, geboren am 28.07.1988, technischer Zeichner bei Bergische Anlagenbau GmbH in Wuppertal. Spätdiagnose Autismus-Spektrum-Störung 2025, zusätzlich ADHS, rezidivierende depressive Episoden. Bisher GdB 30, kein Merkzeichen.

2. Anlass

Änderungsantrag vom 11.03.2026 wurde mit Bescheid vom 19.06.2026 abgelehnt. GdB 30 bleibt. Der Arbeitgeber kündigt ein BEM an; Teamleitung dokumentiert Konflikte wegen Telefonbereitschaft, Großraumbüro und spontaner Prioritätenwechsel. Mandant befürchtet Kündigung.

3. Rentenberaterliche Perspektive

Primär Schwerbehindertenrecht und Teilhabe. Parallel prüfen: Gleichstellung über Agentur für Arbeit, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, medizinische Rehabilitation und nur als Fernpunkt Erwerbsminderungsrente. Arbeitsrechtliche Kündigungsverteidigung separat koordinieren.

Erstgespräch und konkrete Teilhabefolgen

Julian Arendt erschien am 26. Juni 2026 um 08:40 Uhr mit seiner Schwester und einer Mappe der Autismusambulanz. Er arbeitet seit 2017 als technischer Zeichner bei der Bergische Anlagenbau GmbH. Seit dem Umbau zum Großraumbüro im Oktober 2025 häuften sich Migräne, kurzfristige Ausfälle und Situationen, in denen er nach mehreren gleichzeitigen Anforderungen nicht mehr sprechen konnte.

Er wohnt allein und bewältigt bekannte Alltagswege. Probleme entstehen bei kurzfristigen Planwechseln, Telefonunterbrechungen, ungeklärten Zuständigkeiten und dichtem Publikumsverkehr. Als Belege liegen Fehlzeitenlisten, BEM-Einladung, Arbeitsplatzmails, der Ambulanzbericht und ein Reizprotokoll vor. Eine abschließende Erwerbsminderungsfrage ist nicht Gegenstand des laufenden GdB-Widerspruchs.

Datei

Office-Dokument: 02_bescheid_gdb_30.docx

Bescheid GdB 30

1. Entscheidung

Das Versorgungsamt Wuppertal stellt weiterhin GdB 30 fest. Begründung: Die psychische Beeinträchtigung sei fachärztlich bestätigt, jedoch bei stabiler Erwerbstätigkeit und ambulanter Behandlung nicht so ausgeprägt, dass ein höherer Gesamt-GdB gerechtfertigt sei.

2. Ausgelassene Punkte

Der Bescheid erwähnt keine Arbeitsplatzanpassungen, keine sensorische Überforderung, keine dokumentierten Meltdowns und keine stationäre Krisenintervention im Januar 2026. Der Bericht der Autismusambulanz wurde offenbar nur als Diagnosebestätigung gelesen, nicht als Funktionsbeschreibung.

Begründungs- und Anlagenstand des Bescheids

Der Bescheid vom 19. Juni 2026 führt als berücksichtigte Funktionssysteme psychische Störung einschließlich Autismus und ADHS, Migräne sowie Wirbelsäulenbeschwerden auf. Der Ärztliche Dienst bewertet die psychische Beeinträchtigung mit 30 und sieht in den übrigen Diagnosen keine Erhöhung. Zur fortbestehenden Vollzeitbeschäftigung heißt es, eine wesentliche Teilhabestörung sei nicht ausreichend objektiviert.

Im Anlagenverzeichnis werden der Bericht der Autismusambulanz vom 14. Mai, ein Befund von Dr. Reinsch und die Arbeitgeberbescheinigung genannt. Nicht erkennbar ist, ob das Reizprotokoll und die BEM-Einladung ausgewertet wurden. Die Rechtsbehelfsbelehrung nennt eine Monatsfrist ab Bekanntgabe; Julian vermerkte den Zugang am 22. Juni.

Datei

Office-Dokument: 03_autismusambulanz_bericht.docx

Bericht Autismusambulanz

1. Diagnostik

Autismusambulanz Rheinland, Bericht 04.05.2026. Diagnose Autismus-Spektrum-Störung ohne Intelligenzminderung, ADHS kombiniert, ausgeprägte sensorische Reizempfindlichkeit, Schwierigkeiten in spontaner sozialer Kommunikation und im Aufgabenwechsel.

2. Teilhabe

Der Mandant kann hochkonzentriert zeichnen, wenn Aufgaben klar, schriftlich und reizarm sind. Er dekompenziert bei Telefonketten, parallelen Zurufen, wechselnden Prioritäten und unklarer Kritik. Nach solchen Tagen folgen Schlaflosigkeit, Migräne und Ausfallzeiten.

3. Empfehlung

Reizarmer Arbeitsplatz, schriftliche Aufgabensteuerung, keine spontane Telefonvertretung, feste Rückzugszeiten, Jobcoaching. Die Ambulanz hält arbeitsbezogene Teilhabemaßnahmen für dringlich.

Diagnostischer Ablauf und Beobachtung

Die Ambulanz führte zwischen November 2025 und April 2026 vier Termine durch. Einbezogen wurden Entwicklungsanamnese mit der Mutter, schulische Zeugnisse, ADOS-2 Modul 4, Fragebögen zur sozialen Kommunikation und eine differenzialdiagnostische psychiatrische Untersuchung. Hinweise auf eine akute Psychose oder manische Episode ergaben sich nicht.

Im Gespräch zeigte Julian eine präzise sachbezogene Sprache, benötigte bei offenen Fragen aber wiederholt Konkretisierung. Blickkontakt und wechselseitige Gesprächssteuerung waren unter Belastung eingeschränkt. Der Bericht beschreibt keine allgemeine Hilflosigkeit, sondern erhebliche Schwierigkeiten bei Reizfilterung, spontanen Wechseln und sozial uneindeutigen Anforderungen. Empfohlen werden vorhersehbare Abläufe, schriftliche Aufgaben und ein reizärmerer Arbeitsplatz.

Datei

Office-Dokument: 04_arbeitgeber_bem_notiz.docx

Arbeitgebernotiz BEM

1. Fehlzeiten

2025: 47 Arbeitstage arbeitsunfähig, davon 21 nach Konflikten im Großraumbüro. Januar bis Juni 2026: 29 Arbeitstage. BEM-Einladung vom 26.06.2026.

2. Konfliktpunkte

Teamleitung fordert Telefonvertretung bei Projektspitzen. Julian Arendt verweist auf ärztliche Empfehlung, Telefonate planbar zu halten. Am 12.06.2026 verließ er nach einer spontanen Besprechung den Raum und war zwei Tage krankgeschrieben.

3. Arbeitgeberangebot

Homeoffice ein Tag pro Woche, Noise-Cancelling-Kopfhörer erlaubt, aber kein Einzelbüro. Schriftliche Aufgabensteuerung sei wegen Baustellenänderungen nicht immer möglich.

BEM-Termin und betriebliche Beobachtungen

Am 8. Juli 2026 nahmen Julian Arendt, Personalreferentin Anja Feld, Vertrauensperson Meike Vogt und Teamleiter Björn Hagedorn am BEM-Gespräch teil. Die Fehlzeitenliste weist seit November 2025 insgesamt 19 einzelne Ausfalltage aus. Zwei Arbeitstage endeten vorzeitig nach Reizüberlastung; am 23. Juni begleitete Frau Vogt den Mitarbeiter in den Ruheraum.

Besprochen wurden ein fester Arbeitsplatz am Rand des Büros, geräuschkämpfende Kopfhörer, schriftliche Tagesordnungen, keine unangekündigten Raumwechsel und zwei mobile Arbeitstage. Die Arbeitgeberin sagte eine vierwöchige Erprobung ab 13. Juli zu. Eine Leistungsbewertung oder Änderung des Arbeitsvertrags wurde nicht beschlossen. Das Protokoll soll nach Gegenlesen von allen Teilnehmern unterschrieben werden.

Datei

Office-Dokument: 06_widerspruch_entwurf.docx

Widerspruchsentwurf GdB

1. Antrag

Gegen den Bescheid vom 19.06.2026 wird Widerspruch eingelegt. Beantragt wird die Neufeststellung des GdB unter vollständiger Würdigung der psychischen und neuroentwicklungsbezogenen Funktionsbeeinträchtigungen.

2. Begründung

Die Erwerbstätigkeit allein belegt keine geringe Teilhabebeeinträchtigung. Sie gelingt nur unter erheblicher Kompensation und bricht bei Reizüberlastung, Aufgabenwechsel und sozialer Unklarheit wiederholt zusammen. Die Behörde hat die Funktionsauswirkungen im Arbeitsleben und Alltag nicht vollständig erhoben.

3. Beweismittel

Bericht Autismusambulanz, psychiatrischer Befund, BEM-Unterlagen, Fehlzeitenübersicht, Reizprotokoll, Stellungnahme einer Vertrauensperson. Ergänzend wird eine versorgungsmedizinische Begutachtung angeregt, die nicht nur Gesprächsfähigkeit im Termin bewertet.

Tatsachen- und Belegbezug des Widerspruchs

Der Entwurf ordnet jede geltend gemachte Einschränkung einem Beleg zu: Reizüberlastungen dem Arbeitgeberprotokoll, soziale und kommunikative Einschränkungen dem Ambulanzbericht, depressive Episoden dem Befund von Dr. Reinsch und Migränetage dem Behandlungskalender. Die fortbestehende Beschäftigung wird nicht bestritten, sondern mit den bereits erforderlichen Anpassungen und Ausfalltagen beschrieben.

Beantragt wird Akteneinsicht in die vollständige versorgungsärztliche Bewertung und eine erneute Gesamtwürdigung. Die einzelnen Werte werden nicht addiert. Offen bleibt, ob weitere Berichte der behandelnden Psychotherapeutin benötigt werden; eine Schweigepflichtentbindung liegt vorbereitet, aber noch nicht unterzeichnet vor.

Datei

Office-Dokument: 07_gleichstellung_reha_rente.docx

Gleichstellung, Reha und Rente

1. Gleichstellung

Bei GdB 30 kann eine Gleichstellung relevant sein, wenn der Arbeitsplatz wegen der Behinderung gefährdet ist. Die BEM-Unterlagen und Teamnotizen stützen diese Prüfung. Die Antragstellung bei der Agentur für Arbeit muss mit dem GdB-Widerspruch abgestimmt werden.

2. Teilhabe am Arbeitsleben

Jobcoaching, technische und organisatorische Anpassungen, Einzelbüro oder Homeoffice-Anteil sind vorrangig vor Rentendiskussion. Der Rentenberater sollte den Versicherungsverlauf sichern, aber eine Erwerbsminderungsrente erst prüfen, wenn Teilhabemaßnahmen scheitern oder ärztlich nicht ausreichen.

Parallelverfahren und Zuständigkeiten

Julian hat noch keinen Gleichstellungsantrag gestellt. Die Agentur für Arbeit bat vorab um Arbeitsplatzbeschreibung, Gefährdungslage und Angaben zu den bereits erprobten Anpassungen. Das BEM läuft zunächst bis Mitte August. Ein Antrag auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben wird nur vorbereitet, falls die innerbetrieblichen Maßnahmen nicht ausreichen.

Eine Erwerbsminderungsrente ist derzeit nicht beantragt. Julian arbeitet weiter vollzeitig und möchte den Arbeitsplatz erhalten. Medizinische Unterlagen dürfen deshalb nicht ohne Zwecktrennung zwischen GdB-Verfahren, Gleichstellung, Reha und möglicher späterer Rentenprüfung weitergereicht werden. Fristen und Einwilligungen werden in getrennten Registern geführt.

Datei

Office-Dokument: 10_versorgungsaerztliche_stellungnahme_09062026.docx

Versorgungsamt Wuppertal

Ärztlicher Dienst

Aktenzeichen: SB 30-114-2026

Versorgungsärztliche gutachterliche Stellungnahme nach Aktenlage

Datum: 09.06.2026

Betroffener: Julian Arendt, geboren am 28.07.1988, wohnhaft in Wuppertal

1. Auftrag und Grundlagen

1.1 Zu bewerten ist der Änderungsantrag vom 11.03.2026 auf Erhöhung des Grades der Behinderung. Der bisher festgestellte Grad der Behinderung beträgt 30.

1.2 Ausgewertet wurden der Bericht der Autismusambulanz Rheinland vom 04.05.2026, ein nervenärztlicher Kurzbefund sowie die Angaben des Antragstellers im Antragsformular. Eine persönliche Untersuchung hat nicht stattgefunden; die Stellungnahme ergeht nach Aktenlage.

2. Festgestellte Funktionsbeeinträchtigungen und Einzelbewertung

2.1 Die Autismus-Spektrum-Störung ohne Intelligenzminderung ist fachärztlich gesichert. Da der Antragsteller in Vollzeit als technischer Zeichner erwerbstätig ist und sich im Untersuchungsgespräch sprachlich geordnet und kooperativ gezeigt hat, wird der Einzel-Grad der Behinderung mit 30 bewertet.

2.2 Die rezidivierende depressive Störung wird bei ambulanter Behandlung und ohne aktenkundige stationäre Behandlung mit einem Einzel-Grad der Behinderung von 20 eingeschätzt.

2.3 Eine kombinierte Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung sowie eine Migräne sind erwähnt, führen nach hiesiger Einschätzung zu keiner eigenständigen Erhöhung.

3. Bildung des Gesamt-Grades der Behinderung

3.1 Der Gesamt-Grad der Behinderung wird nicht durch Addition der Einzelgrade gebildet, sondern nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen unter Würdigung der wechselseitigen Beziehungen. Ausgehend vom führenden Wert 30 rechtfertigt die zusätzliche depressive Störung nach hiesiger Auffassung keine Anhebung, weil beide Beeinträchtigungen dasselbe Funktionssystem betreffen.

3.2 Es wird vorgeschlagen, den Gesamt-Grad der Behinderung unverändert mit 30 festzustellen. Eine erhebliche Teilhabebeeinträchtigung ist bei fortbestehender Erwerbstätigkeit nicht hinreichend belegt.

4. Anmerkung für die Widerspruchsstelle

4.1 Diese Stellungnahme berücksichtigt die im Antrag nicht näher dokumentierte stationäre Krisenintervention im Januar 2026 nicht, da hierzu kein Entlassungsbericht vorliegt. Ein solcher Bericht sowie eine funktionsbezogene Beschreibung der Arbeitsplatzsituation wären vor einer abschließenden Entscheidung beizuziehen.

gez. Dr. med. Ulrike Sander

Ärztlicher Dienst, Versorgungsamt Wuppertal

Datei

Office-Dokument: 11_nervenaerztlicher_befundbericht_reinsch.docx

Praxis Dr. med. Thomas Reinsch

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

Friedrich-Ebert-Straße 118, 42117 Wuppertal

Nervenärztlicher Befundbericht zur Vorlage im Widerspruchsverfahren

Datum: 28.06.2026

Patient: Julian Arendt, geboren am 28.07.1988

1. Behandlungsverlauf

1.1 Herr Arendt befindet sich seit der Spätdiagnose einer Autismus-Spektrum-Störung im Jahr 2025 in meiner regelmäßigen fachärztlichen Behandlung. Die Diagnostik wurde durch die Autismusambulanz Rheinland gesichert; ihr Bericht vom 04.05.2026 liegt vor.

1.2 Im Januar 2026 war eine stationäre Krisenintervention erforderlich, nachdem es nach einer Phase kumulierter Reizüberlastung am Arbeitsplatz zu einer depressiven Dekompensation mit Rückzug und Schlaflosigkeit gekommen war.

2. Diagnosen

2.1 Autismus-Spektrum-Störung ohne Intelligenzminderung mit ausgeprägter sensorischer Reizempfindlichkeit und erheblichen Schwierigkeiten bei Aufgabenwechsel und spontaner sozialer Kommunikation.

2.2 Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episoden im Wechsel mit teilremittierten Phasen.

2.3 Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kombinierter Typ.

2.4 Chronische Migräne mit Häufung nach Belastungstagen.

3. Funktions- und Teilhabebeschreibung

3.1 Herr Arendt kann hochkonzentriert und fehlerarm arbeiten, wenn Aufgaben klar, schriftlich und reizarm gestellt sind. Er dekompensiert regelhaft bei Telefonketten, parallelen Zurufen, wechselnden Prioritäten und unklarer Kritik. Auf solche Tage folgen Schlaflosigkeit, Migräne und Arbeitsunfähigkeit.

3.2 Die fortbestehende Erwerbstätigkeit ist kein Beleg geringer Beeinträchtigung, sondern gelingt nur unter hoher und erschöpfender Kompensation. Die dokumentierten Ausfallzeiten und die Krisenintervention im Januar 2026 belegen die Grenzen dieser Kompensation.

4. Sozialmedizinische Einschätzung der Einzelgrade

4.1 Die Autismus-Spektrum-Störung führt zu stärker behindernden Auswirkungen im Arbeits- und Alltagsleben; ich halte hierfür einen Einzel-Grad der Behinderung von 40 für sachgerecht und führend.

4.2 Die rezidivierende depressive Störung ist gegenüber der Grunderkrankung eigenständig abgrenzbar und rechtfertigt einen Einzel-Grad der Behinderung von 30.

4.3 Für die kombinierte Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ist ein Einzel-Grad der Behinderung von 20 anzusetzen, der sich weitgehend mit der Autismus-Spektrum-Störung überschneidet. Die chronische Migräne bewerte ich mit 10.

4.4 Aus fachärztlicher Sicht ist die Bildung eines Gesamt-Grades der Behinderung von 50 gut begründbar, weil die eigenständige depressive Störung den führenden Wert anhebt. Die versorgungsärztliche Fortschreibung des Wertes 30 wird der dokumentierten Funktionslage nicht gerecht.

gez. Dr. med. Thomas Reinsch

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie